

中医辨证护理与营养护理 对糖尿病肾病患者症状的影响

吴先凡 张贵巧 李 婷 王孝宇
(贵州中医药大学第二附属医院, 贵州 贵阳 550001)

【摘要】目的:探究中医辨证护理与营养护理对糖尿病肾病患者症状的改善效果。方法:以我院2021年1月至2023年12月收治的糖尿病肾病患者180例为研究对象,按照随机抽签方式将患者划分组别,对照组开展常规护理,观察组开展中医辨证护理联合营养护理,观察患者各项指标变化。结果:护理前两组患者血糖指标无显著差异($P>0.05$)。护理后观察组血糖指标较对照组降低更明显,可见对比差($P<0.05$)。护理前两组患者肾功能指标无显著差异($P>0.05$)。护理后观察组各项指标较对照组改善更明显,可见对比差($P<0.05$)。护理前两组患者糖尿病特异性生存质量量表(DQOL)评分未见差异($P>0.05$);护理后观察组分值较对照组降低更明显,可见对比差($P<0.05$)。两组患者满意度对比差异显著($P<0.05$)。结论:糖尿病肾病患者开展中医辨证护理联合营养护理效果显著,可以有效改善患者血糖指标,提高患者生活质量,为患者营造良好的康复环境,值得临床推广。

【关键词】糖尿病肾病 中医辨证护理 营养护理

DOI:10.20255/j.cnki.issn1674-9561.2024.20.023

糖尿病肾病是糖尿病常见的并发症之一,属于糖尿病微血管病变,会导致肾脏功能与结构破坏^[1]。发病后患者会出现明显的肾功能减退,影响身体健康。临床研究认为,对患者开展合理的护理干预可以有效改善其病情^[2],延缓疾病进展,但传统常规护理效果单一,尤其是在部分患者身体功能变化明显,机体代谢失衡的情况下,容易出现营养不良,影响患者康复进程^[3]。因此,临床上提出中医辨证护理与营养护理,两种模式可以有效改善患者症状,减轻病症对患者的影响,优化患者生理状态^[4]。中医辨证护理利用中医“四诊”理念评估患者病情变化,而营养护理注重优化饮食结构,以保护肾功能,促进患者尽早恢复生理机能,对于病情控制具有积极意义^[5]。本研究选取180例患者为样本,分析中医辨证护理与营养护理的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年1月至2023年12月我院收治的180例糖尿病肾病患者作为研究对象,按照随机抽签方式将患者划分组别,对照组90例,男46例、女44

例;年龄43~70岁,平均年龄(56.41 ± 2.13)岁;病程6~14年,平均病程(10.25 ± 1.10)年。观察组90例,男45例、女45例;年龄42~71岁,平均年龄(56.38 ± 2.11)岁;病程6~13年,平均病程(10.05 ± 1.07)年。两组患者一般资料无显著差异($P>0.05$),符合研究要求。

纳入标准:①全部患者均存在水肿、蛋白尿等症状。②患者知情同意并签署知情同意书。③患者无其他并发症,如糖尿病酮症。

排除标准:①精神障碍患者。②合并重要脏器功能障碍患者。③恶性肿瘤患者。

1.2 方法

对照组实施常规护理。对患者进行饮食指导,限制糖分、高蛋白摄入,按时服药,监测血糖指标。

观察组实施中医辨证护理联合营养护理。①中医辨证护理。气阴两虚证患者多受情志、生活、饮食因素影响,护理时需要尽量以补气滋阴为主,控制患者日常饮食,禁忌辛辣刺激性食物,多食粗纤维食物,以促进胃肠蠕动。确保患者作息规律、睡眠充足。推荐进行合理的有氧运动,控制情绪,注重保暖,及时更换衣物。可以选择西瓜皮、冬瓜皮、天花粉,各

12 g 煎水服用以辅助治疗。阴阳两虚证多受不良习惯、久治不愈因素影响,护理应以阴阳双补为原则,指导患者规律休息,适当开展运动,记录尿量,测量早、中、晚时段的血压与体重。如果患者大便不成形,应给予金樱子、益智仁以涩肠止泻。控制饮食,尽量选择枸杞子、银耳等补阴类食物及羊肉、生姜等温阳类食物。脾肾气虚症患者多受劳欲过度、久病体虚影响,护理以健脾益肾为原则,日常禁忌重体力劳动,避风寒,保持健康生活方式,规律作息,禁吸烟、饮酒,禁辛辣食物,增加膳食纤维,保证饮水。肝肾阴虚症患者多受温热病邪耗伤因素影响,需要益肾养肝,指导患者闭目养神以缓解不适感;腰膝酸软患者可以进行关元穴、涌泉穴按摩。②营养护理。对患者进行营养状态评估,包括体脂率、体重等,以了解患者营养状况,制订饮食计划,明确营养不良类型。与家属沟通交流,了解患者饮食偏好,以营养评定结果为基础,制定个性化饮食方案。尽量以粗粮为主,优先选择水果、坚果、奶类,增加新鲜蔬菜摄入量,严格控制糖和蛋白质的摄入量,禁忌辛辣与油炸类食物。做好营养健康宣教,详细解释相关知识,提高患者及家属的认知,指导其合理进行营养搭配。发放健康手册,提高患者依从性。

1.3 观察指标

(1) 观察患者血糖指标。包括空腹血糖(FPG)、餐后2 h 血糖(2 hPG),抽取患者清晨空腹静脉血(3 mL),离心处理,3 200 r/min,取上清液测量。

(2) 观察患者肾功能。包括血尿素氮(BUN)、血肌酐(Scr)、尿蛋白(PRO),抽取清晨空腹外周静脉血,3 200 r/min 离心 10 min,取上清液,选择比色法与艾司巴赫氏定量法测量。

(3) 观察患者糖尿病特异性生存质量量表

(DQOL)评分^[6]。包含职业相关忧虑程度、疾病相关忧虑程度等46个条目,单一条目分值1~5分,分值低表示质量优。

(4) 观察患者满意度。自拟问卷,以非常满意、满意、不满意开展评估,计算满意度比值。

1.4 统计学方法

通过SPSS 27.0处理数据。以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示计量资料,以 t 检验;以 $[n(\%)]$ 表示计数资料,以 χ^2 检验。 $P < 0.05$ 说明差异显著。

2 结果

2.1 两组患者血糖指标对比

护理前两组患者血糖指标未见显著差异($P > 0.05$)。护理后观察组血糖指标较对照组降低更明显($P < 0.05$),见表1。

表1 两组患者血糖指标对比 ($\bar{x} \pm s$, mmol/L)					
组别	<i>n</i>	FPG		2 hPG	
		护理前	护理后	护理前	护理后
观察组	90	8.62 ± 1.21	7.46 ± 0.35	11.26 ± 1.26	9.50 ± 1.22
对照组	90	8.63 ± 1.18	8.07 ± 0.37	11.25 ± 1.25	10.61 ± 1.24
<i>t</i>		0.056	11.362	0.053	6.054
<i>P</i>		0.955	<0.001	0.957	<0.001

2.2 两组患者肾功能指标对比

护理前两组患者肾功能指标未见显著差异($P > 0.05$)。护理后观察组各项指标均较对照组改善更明显($P < 0.05$),见表2。

2.3 两组患者DQOL评分对比

护理前两组患者DQOL评分未见显著差异($P > 0.05$);护理后观察组分值较对照组降低更明显($P < 0.05$),见表3。

表2 两组患者肾功能指标对比 ($\bar{x} \pm s$)							
组别	<i>n</i>	BUN (mmol/L)		Scr (μmol/L)		PRO (g/L)	
		护理前	护理后	护理前	护理后	护理前	护理后
观察组	90	6.83 ± 0.35	5.54 ± 0.29	134.58 ± 2.90	115.84 ± 2.60	2.31 ± 0.15	1.21 ± 0.15
对照组	90	6.85 ± 0.32	6.15 ± 0.33	134.49 ± 2.88	125.45 ± 2.54	2.32 ± 0.17	1.94 ± 0.20
<i>t</i>		0.400	13.172	0.209	25.082	0.418	27.702
<i>P</i>		0.690	<0.001	0.835	<0.001	0.676	<0.001

表3 两组患者DQOL评分对比 ($\bar{x} \pm s$, 分)			
组别	<i>n</i>	DQOL评分	
		护理前	护理后
观察组	90	142.44 ± 2.42	133.63 ± 3.10
对照组	90	142.42 ± 2.40	138.17 ± 3.08
<i>t</i>		0.056	9.856
<i>P</i>		0.956	<0.001

2.4 两组患者满意度情况对比

观察组患者满意度较对照组更高 ($P < 0.05$), 见表 4。

表4 两组患者满意度对比 [n (%)]

组别	n	非常满意	满意	不满意	满意率
观察组	90	53 (58.89)	35 (38.89)	2 (2.22)	88 (97.78)
对照组	90	50 (55.56)	33 (36.67)	7 (7.78)	83 (92.22)
χ^2					4.211
P					0.040

3 讨论

糖尿病肾病属于微血管并发症, 对人体产生的危害较大, 会导致患者肾功能降低、肾脏负担增加^[7], 因此需要加强重视, 以减轻病症危害。病情发展阶段不同症状存在一定的差异^[8], 通过中医辨证护理与营养护理可以明确患者病症类型及病变情况, 开展针对性护理^[9], 改善患者生理机能, 提高护理针对性与灵活性^[10], 及时清除存在的风险因素, 降低并发症发生率, 发挥出护理优势。同时, 这种护理模式还可以提高患者健康知识水平, 促进自我管理, 提高依从性, 延缓病症进展^[11]。

本研究结果显示, 护理前两组患者血糖指标无显著差异 ($P > 0.05$)。护理后观察组血糖指标较对照组降低更明显 ($P < 0.05$), 说明该联合护理方式可以有效控制患者血糖指标, 保证其血糖稳定, 减轻对患者身体产生的损伤^[12], 优化患者自身状态, 促使患者尽早恢复正常生理机能。分析原因, 该护理方式可以明确患者病症类型, 针对性开展护理与指导, 提高护理精准性, 控制膳食结构, 以达到降低血糖的目的。护理前两组患者肾功能指标无显著差异 ($P > 0.05$)。护理后观察组各项指标改善较对照组更明显 ($P < 0.05$), 说明该护理方式可以优化患者肾功能, 降低患者肾脏负担, 并通过运动、饮食指导改善患者病情, 促使患者尽早恢复。护理前两组患者 DQOL 评分未见显著差异 ($P > 0.05$); 护理后观察组分值降低更明显 ($P < 0.05$), 说明该护理方式可以提高患者生活质量。分析原因, 该护理模式根据患者病症类型进行干预, 从根源上控制病情进展, 有助于患者生理机能提升, 达到改善症状的目的, 从而提高患者生活质量。两组患者满意度结果可见显著差异 ($P < 0.05$), 说明患者对该护理模式较为认可。

综上所述, 糖尿病肾病患者开展中医辨证护理与营养护理效果明显, 有助于降低患者血糖指标, 保证其血糖稳定, 改善其肾功能指标, 提高其生存质量, 减轻其压力, 价值显著。

【参考文献】

[1] 甘雨珍. 饮食护理干预对糖尿病肾病病人饮食治疗依从性及营养状况的影响 [J]. 中国食品工业, 2023, (23): 123-125.

[2] 时瑞雪, 王灿, 田硕. 常规护理与饮食营养护理对糖尿病肾病维持性血液透析患者预后恢复的影响 [J]. 糖尿病新世界, 2023, 26 (22): 165-167, 175.

[3] 王文翠. 强化营养支持护理联合健康宣教对糖尿病肾病患者营养知识认知、遵医行为及血糖控制的影响 [J]. 临床医学研究与实践, 2021, 6 (33): 183-185.

[4] 张彩云, 陈楠. 综合饮食护理对糖尿病肾病血液透析患者营养状况与生活质量的影响 [J]. 中华养生保健, 2023, 41 (16): 8-11.

[5] 彭志红. 饮食护理对糖尿病肾病维持性血液透析患者营养状况的干预效果分析 [J]. 婚育与健康, 2023, 29 (10): 160-162.

[6] 王瑞青, 方钦, 卓蕾艳. 个体化饮食护理干预对糖尿病肾病患者临床治疗依从性的影响 [J]. 糖尿病新世界, 2023, 26 (10): 169-172.

[7] 范焕新. 营养管理联合有氧运动对维持性血液透析老年病人护理效果的影响 [J]. 循证护理, 2023, 9 (9): 1701-1704.

[8] 梁伟玲, 陈泽芝, 陈婉. 饮食护理与健康教育在糖尿病肾病维持性血液透析中的应用效果分析 [J]. 糖尿病新世界, 2023, 26 (6): 107-110.

[9] 李恽毅, 蔡佳盈, 吴岑. 针对性营养护理对维持性血液透析患者营养状态的影响 [J]. 中国卫生标准管理, 2023, 14 (5): 184-188.

[10] 李玫艳, 林东升. 营养饮食护理模式对糖尿病肾病患者饮食治疗依从性的影响 [J]. 中国医药指南, 2023, 21 (7): 159-161.

[11] 谢雅荣, 江荣. 认知行为护理结合饮食护理对糖尿病肾病血液透析患者营养状况及肾功能的影响 [J]. 透析与人工器官, 2021, 32 (4): 75-76.

[12] 梁伟玲, 陈泽芝, 陈婉. 饮食护理与健康教育在糖尿病肾病维持性血液透析中的应用效果 [J]. 糖尿病新世界, 2023, 26 (4): 136-139.